GLIP_최종기획안_v2

GLIP 최종 기획안 (v2)

> **GLIP — GLP-1 투약자를 위한 아바타 셀프케어 앱. 약을 쓰는 동안에도, 끊은 뒤에도.**
> GLP-1 약 이야기에 **나(I)**를 넣었습니다. 약이 아니라, 약을 쓰는 사람을 돌봅니다.

> **v2에서 바뀐 점**
>
> - 1-1 처방 추세 꺾은선그래프 추가
> - 1-2 중요도 낮은 데이터 3개 취소선
> - 1-3 "부작용은 흔한데 약을 끊는 사람은 적다" 강조
> - 기존 1-4(약을 끊으면 체중이 돌아온다) → 4-4 요요 솔루션 앞으로 이동
> - self-care 정의를 짧고 선명하게 (1-4)
> - 2-1 금융사들이 시장을 크게 보는 이유 추가
> - 2-3 경쟁사 언급 빼고, 중단 후 실제 사례와 사후관리 부재를 비판한 보도로 교체

발표 흐름 한눈에 보기

#	섹션	한 줄 메시지
1	Problem	처방은 폭증했지만, 약을 쓰는 동안 내 몸을 살피는 **self-care**는 비어 있다.
2	Market	국내 GLP-1 비만약은 분기 매출 5천억 원대. 그런데 **약을 끊은 뒤는 아무도 돌보지 않는다.**
3	Persona	외모 때문에 투약을 이어가는 22세, 약을 끊고 식욕이 돌아온 42세, 진료 시간이 짧은 담당 의사
3.5	GLIP	GLP-1 → GLIP. 내 상태를 비춰주는 새싹 캐릭터
4	Solution	아바타가 몸 상태를 비춰주고(Avatar-mediated self-awareness), 투약 단계에 따라 돌봄이 달라진다(Patient journey–adaptive care).
5	Competitors	국내 앱은 약이나 식단을 기록할 뿐, 끊은 뒤와 병원 연결까지 이어지지 않는다.
6	TAM/SAM/SOM	환자 약 112만 명, 의원 약 1.6만 곳. 공개 자료로 계산한 연 194억 원 시장 (기본 시나리오)
7	BM	매출의 중심은 **병원 차팅 서비스**. 꾸미기는 매출보다 지속 사용을 위한 장치
8	Roadmap	MVP → 병원 파일럿 → 유료 전환 → 데이터 기반 확장
9	Validation	사용자·임상·사업 검증 계획, 그리고 요요 예측 모델은 Further work

1. Problem

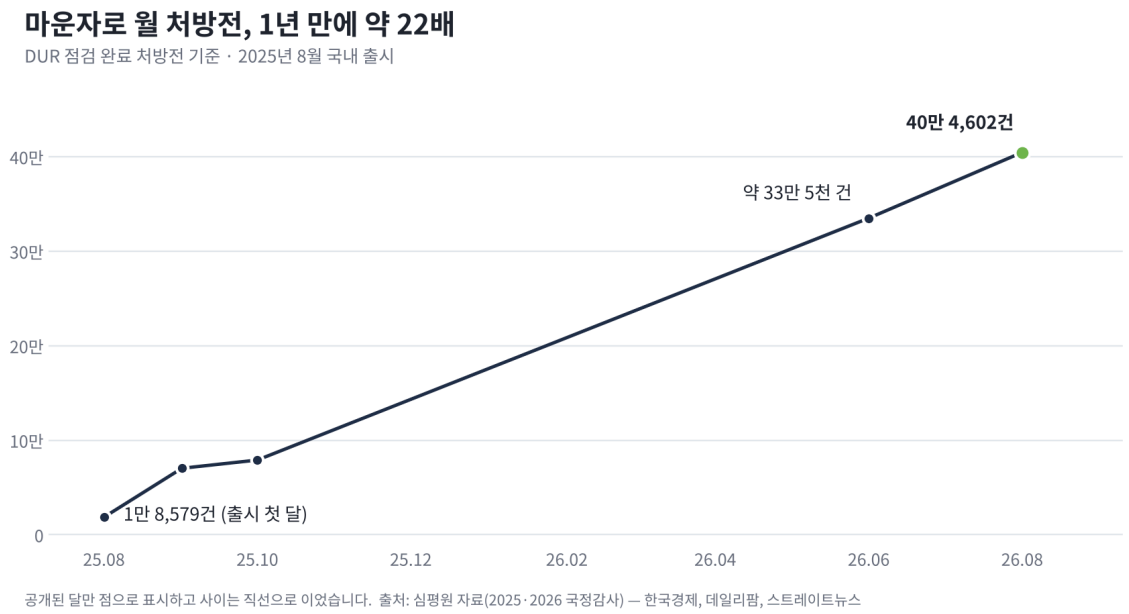
> **"우리는 몸을 '보여주기 위해' 관리할 뿐, '살아가기 위해' 돌보지 않게 되었습니다."**

1-1. 처방은 폭발적으로 늘었습니다

- 위고비와 마운자로의 처방전(DUR 점검 완료 기준)은 **2024년 4만 9,815건 → 2025년 약 122만 건 → 2026년 상반기에만 약 186만 건**입니다. [1]

- 2025년 8월에 나온 마운자로는 첫 달 약 1만 9천 건에서 **10개월 만에 월 33만 5천 건으로 18배** 늘었습니다. [1] 2026년 8월에는 한 달에만 **40만 4,602건**이 처방됐습니다. [29]

마운자로 월 처방전 추이



마운자로 월 처방전 추이

[그래프: chart_mounjaro_prescriptions.png — 노션에서 이미지가 안 보이면 이 파일을 여기에 붙여넣기]

1-2. 처방은 쉬워졌지만, 점검은 비어 있습니다

- ~~정상 체중인 사람도 비교적 쉽게, 몇 분 만에 처방받을 수 있다는 지적이 국정감사에서 나왔습니다. [2]~~
- ~~위고비 처방의 46.4%가 20~30대에 몰려 있습니다. [3]~~
- 위고비 DUR 점검 129만 건 중 76.9%에서 경고가 떴지만, 그중 **97.3%는 처방을 바꾸지 않고 그대로** 나갔습니다. [4]
- ~~만 18세 미만 사용이 금지된 약인데도 10대 처방이 1만 2천여 명에 이릅니다. [5]~~

1-3. 투약 중: 부작용은 흔하고, 위험 신호는 놓치기 쉽습니다

> **부작용은 흔한데, 약을 끊는 사람은 적습니다.**
> 임상시험(SURMOUNT-1)에서 마운자로 사용자의 **최대 3명 중 1명(24.6~33.3%)이 메스꺼움**, 5명 중 1명(18.7~23.0%)이 설사, 8.3~12.2%가 구토를 겪었습니다. 그런데 부작용 때문에 약을 그만둔 사람은 **4.3~7.1%뿐**입니다. [6]
> → 대부분은 **증상을 안고 그대로 약을 계속 맞는다**는 뜻입니다. 게다가 이 숫자는 의료진이 정기적으로 증상을 확인해 준 임상시험의 결과입니다. 실제 처방 현장에서는 그 확인이 없습니다.

- 국내 시판 이후 2026년 6월까지 식약처에 보고된 이상사례는 **2,705건**(위고비 1,444건, 마운자로 1,261건)입니다. [4]
- 위고비 투약자 중 담석증 환자는 2025년 8월 560명에서 **2026년 8월 3,399명으로 6.1배** 늘었습니다. [4]
- 허가사항은 구토·설사로 인한 탈수가 **급성 콩팥 손상**으로 이어질 수 있고, 췌장염·담낭 질환도 생길 수 있다고 경고합니다. [7]

문제는 사용자가 이 신호들을 **“살 빠지는 과정이니 참아야지”** 하고 넘긴다는 점입니다. 참아도 되는 증상과 병원에 가야 하는 증상을 구분해 줄 장치가 없습니다.

1-4. 그래서 문제는 “self-care의 공백”입니다

> 보통 ’케어’라고 하면 복지, 돌봄 서비스, 취약계층을 떠올립니다.
> GLIP이 말하는 케어는 다릅니다. **내가 나를 돌보는 것, self-care**입니다.

약은 체중을 줄여 주지만, 내 몸을 돌봐 주지는 않습니다. 살을 빼야 한다는 압박 속에서는 메스꺼움도, 다시 붙는 체중도 “내가 참으면 되는 일”이 됩니다. 처방 이후 비어 있는 것은 의료가 아니라, **스스로를 돌보는 힘**입니다.

> **약은 효과적이지만, 처방 이후 self-care의 공백이 건강을 해칩니다.**

→ 이 공백은 처방이 늘수록 커집니다. 그럼 시장은 얼마나 클까요?

---

2. Market Research & Growth Potential

2-1. 세계 시장: GLP-1 시장의 확대는 확실합니다

- J.P. Morgan: 2030년 인크레틴(GLP-1 계열) 시장 **2,000억 달러** 전망 [12]
- Morgan Stanley: 비만 치료제 시장 **15배 이상** 성장 가능성 [13]
- Goldman Sachs: 2030년 **950억 달러** 전망(이전 전망보다 낮췄지만 여전히 큰 시장) [14]

왜 이렇게 크게 볼까요? 비만은 전 세계 수억 명이 가진 만성질환인데, 아직 약을 쓰는 사람은 그중 일부에 불과합니다. 여기에 체중뿐 아니라 당뇨·심혈관 질환 같은 동반질환까지 좋아진다는 근거가 쌓이고, 먹는 약 같은 새 제형이 나오면서 약을 쓸 수 있는 사람과 쓰임새가 계속 넓어지고 있기 때문입니다.

2-2. 국내 시장: 분기 5천억 원대로 커졌습니다

분기 (아이큐비아)	마운자로	위고비
2025년 3분기	294억 원	1,420억 원
2025년 4분기	1,916억 원	-
2026년 1분기	3,232억 원	-
2026년 2분기	**4,212억 원**	**1,130억 원**

- 2026년 2분기 두 약을 합치면 **5,342억 원**, 1년으로 환산하면 **약 2.1조 원**입니다. [15]
- GLP-1 비만약을 공급받은 의원은 **위고비 1만 6,047곳, 마운자로 1만 4,525곳**입니다. 의료기관 공급량 중 의원급 비중은 88~92%입니다. [16]
- 국내 성인 비만 유병률은 **38.4%**(남성 49.8%, 여성 27.5%)로, 약을 쓸 수 있는 사람은 앞으로도 많습니다. [17]

2-3. 빈자리: 약을 끊은 뒤는 아무도 돌보지 않습니다

실제로 일어나고 있는 일

- 위고비로 체중을 뺀 유명 유튜버가 약을 끊은 뒤 체중이 다시 늘고 있다고 직접 밝혔고, 비슷한 경험담이 이어지고 있습니다. [35][36]
- “8kg 빠져 위고비 끊자 다시 쪘다” — 약을 중단한 뒤 체중이 다시 느는 사례가 늘면서, **약 이후의 체중 유지가 치료의 핵심 단계**로 옮겨 가고 있다는 보도가 나왔습니다. [37]

그런데 관리 체계는 비어 있습니다

- 대한비만학회는 부작용 모니터링과 함께 **처방 후 추적 관리 체계를 강화해야 한다**고 공개적으로 지적했습니다. [38]
- GLP-1 비만약은 대부분 비급여라, 실제로 약을 쓴 사람들의 데이터로 안전성을 지켜보는 데 한계가 있다는 전문가 지적이 나왔습니다. [39]
- 국회에는 '비만 관리법' 3건이 2년 가까이 계류 중이고, 정부 차원의 장기 관리 체계가 먼저라는 목소리가 이어집니다. [40]

> **처방은 늘었지만, 약을 끊은 뒤의 요요 관리와 병원 재연결은 누구의 몫도 아닙니다. → 블루오션**
> (이미 나와 있는 서비스와의 비교는 5장에서 자세히 다룹니다.)

2-4. 제도 흐름도 "처방 후 관리" 쪽으로 움직입니다

- 식약처는 2026년 6월 GLP-1 제제를 **오남용 우려 의약품**으로 지정하는 고시안을 행정예고했습니다. [5]
- 비대면진료 법제화가 2025년 12월 국회를 통과해 2026년 12월 시행을 앞두고 있습니다. 진료 사이의 환자 상태를 의사에게 전달하는 도구의 가치가 커집니다.

→ 그럼 이 빈자리에서 가장 도움이 필요한 사람은 누구일까요?

---

3. 타겟 사용자와 페르소나

> Persona 1(요요가 불안한 사용자)은 요요 관리가 핵심 기능이 되면서 Persona 3에 합쳤습니다.

Persona 2. 외모 강박으로 투약을 이어가는 20대

22세 대학생 | 과체중에서 정상 체중으로 감량

체중을 줄이려고 마운자로를 시작했고 정상 체중에 도달했지만, 여전히 외모가 만족스럽지 않습니다. 더 날씬해져야 한다는 생각에 투약을 이어갑니다. 가끔 오는 메스꺼움은 참을 만하다고 여기고, 최근 구토까지 생겼지만 살 빼는 과정에서 감수할 일이라고 생각합니다.

- **Pain Point:** 왜곡된 신체 이미지 · 부작용의 심각성을 모름
- **Need:** 외모와 체중 중심의 판단에서 벗어나 **몸의 위험 신호를 알아차리고, 필요할 때 도움을 요청할 수 있는 도구**
- **GLIP이 하는 일:** 구토와 탈수에 가중치를 두어 캐릭터가 시들고, 위험 증상이면 점수와 상관없이 바로 경고와 병원 안내를 띄웁니다.

Persona 3. 투약을 끊은 뒤 식욕 조절이 어려운 40대

42세 직장인 | 마운자로 중단 후 식욕 증가

체중 감량 후 마운자로를 끊었지만, 식욕이 크게 늘어 식사량을 조절하기 어렵습니다. 바쁜 일상 속에서 끼니와 간식이 불규칙하고, 하루 동안 무엇을 얼마나 먹었는지도 기억하지 못합니다. 이대로라면 체중이 다시 늘 것 같아 체계적인 관리가 필요하다고 느낍니다.

- **Pain Point:** 식욕 증가 · 식습관 파악과 자기 관리의 어려움
- **Need:** 기록 부담을 줄이면서 식사 패턴을 파악하고, 체중이 돌아오기 시작하면 **일찍 알려주는 도구**
- **GLIP이 하는 일:** 식사 사진만 찍으면 AI가 단백질·채소·정제 탄수화물 여부를 표시하고, 주 1회 체중으로 신호등을 켜서 노랑불부터 대응합니다.

Persona 4. 비만 진료를 하는 담당 의사

46세 의원 원장 | 하루 비만 진료 환자 수십 명

진료 시간은 짧은데 환자가 지난 4주 동안 어떤 부작용을 겪었는지 정확히 기억해 오는 경우는 드뭅니다. 약을 끊은 환자는 병원에 다시 오지 않아 이후 상태를 알 수 없습니다.

- **Pain Point:** 진료 사이의 환자 상태를 모름 · 중단 후 환자 추적 불가
- **Need:** 진료 전에 한눈에 보는 요약, 다시 봐야 할 환자를 먼저 알려주는 목록
- **GLIP이 하는 일:** 환자가 동의하면 4주 리포트와 빨간불 알림을 병원 대시보드로 보냅니다.

사용자 유형별 관리 초점

구분	치료 목적 환자	체중 관리 목적 환자	담당 의사
대표 사용자	비만·동반질환으로 처방받은 사용자	외모·체중 감량이 주목적인 사용자	처방하는 의사 (진료과 제한 없음)
추가 위험	당뇨약(인슐린·설폰요소제) 병용 시 저혈당	과도한 절식, 영양 결핍, 근손실	진료 사이 정보 공백
예상 순응도	체크리스트·알림을 귀찮아할 수 있음	기록을 열심히 할 가능성이 높음	추가 업무를 싫어함
관리 초점	체지방 감소 + 관절 부담을 고려한 운동	단백질·수분 보충, 위험 신호 인식	요약 리포트, 빨간불 우선 표시

→ 이 세 사람을 한 앱으로 돌보는 것이 GLIP입니다.

3.5 GLIP을 소개합니다

`[이미지: GLIP 캐릭터 — 픽셀 새싹 머리, 체형 3종 × 상태 5단계]`

- **이름:** GLP-1 + **I** = GLIP. 약(GLP-1) 이야기에 사람(I)을 넣었습니다.
- **발표 연출:** 화면의 “GLP-1” 글자가 스르륵 바뀌며 “GLIP”이 되는 전환 효과
- **캐릭터:** 머리에 새싹이 난 픽셀 캐릭터. 사용자가 체형을 직접 고르고, 상태에 따라 새싹과 표정이 달라집니다.

> **“GLP-1 투약자의 self-care를 돕는 앱, GLIP입니다.”**

---

4. Solution

> **“나를 비춰주는 아바타와, 내게 필요한 순간에 달라지는 돌봄.”**

핵심 아이디어 1. Avatar-mediated self-awareness (아바타로 나를 보기)

Self-care에서 가장 중요한 것은 명령이나 강요 없이 **스스로 깨닫게** 하는 것입니다.

거울 속 내 모습은 이미 말랐어도 뚱뚱해 보일 수 있습니다(신체 이미지 왜곡). 하지만 내가 이입한 캐릭터가 시들시들한 모습을 보면 “나를 좀 챙겨야겠다”는 마음이 듭니다. 아바타는 **나와 같으면서도 한 발 떨어져서 볼 수 있게** 해줍니다. 게임화 연구에서도 피드백과 아바타는 건강 행동을 바꾸는 데 가장 효과적인 요소였습니다. [19]

핵심 아이디어 2. Patient journey–adaptive care (투약 단계에 맞춘 돌봄)

GLP-1 사용자의 필요는 투약 단계에 따라 바뀝니다.

단계	주된 걱정	GLIP이 보는 것
투약 중	부작용, 영양 부족	증상 → 캐릭터 상태
투약 후	식욕 증가, 요요	생활습관 → 캐릭터 상태, 체중 → 신호등

알림 빈도, 식사 가이드, 캐릭터 반응을 단계와 상태에 맞춰 바꾸고, 투약 중부터 중단 후까지 **끊기지 않는 관리**를 만듭니다.

4-1. 전체 흐름

[이미지: 워크플로우 구조도]

~~**가입** → **처방 중**(부작용 관리) → **약 중단** → **중단 후**(생활습관 + 체중 관리) → 빨간불이면 **병원 연결** → 다시 처방 받으면 처음으로~~

~~**앱 안의 점수는 두 가지입니다.**~~

	캐릭터 상태 (1~5단계)	새싹 (앱 화폐)
무엇을 보여주나	지금 내 몸과 생활습관 상태	기록한 노력
어디에 쓰이나	캐릭터 표정·자세·새싹 모양	꾸미기 아이템 교환
성격	거울 (보상이 아님)	보상

> ~~증상이 심해도, 체중이 늘어도 **기록만 하면 새싹은 똑같이 쌓입니다.** 그래야 숨기지 않고 솔직하게 기록합니다.~~

~~4-2. 가입할 때 (1번만)~~

- ~~시작 체중, 현재 용량, 주사 요일을 입력합니다.~~
- ~~기저질환, 병용 약물에 따라 개인별 앱 튜닝 ex.신장질환이 있으면 → 단백질 목표를 보여주지 않음. 등~~

4-3. 처방 중: 부작용 관리

(요약본) 4-3. 처방 중: 부작용 관리

▼ 예시

상황: 구토 및 수분 섭취 어려움 발생

1 앱 초기 화면. 아바타가 화면에 나오고,

2 아바타의 가슴부분에 '속이 불편해요'를 터치하자 체크리스트 뜸(4개).

3 사용자가 체크리스트를 체크함. 그중 세부 항목에서 '평소보다 토하는 일이 잦아졌어요'를 체크하는 화면을 제시.

4 캐릭터 가 말풍선 떠서 상세문진(3개) 뜸. 심해요(일상이 어려움)', '거의 못 먹고 마셨어요', '오늘부터'*

5 어제: 캐릭터 4단계 > 오늘 기록: ~~구토 2점 + 수분 섭취 어려움 2점~~

상태 변화: 캐릭터 4단계 → 2단계

시각적 변화: 지친 표정, 움츠러든 자세, 시든 새싹

핵심: 증상 기록이 캐릭터의 변화로 이어져, 자신의 건강 상태를 직관적으로 인식

① 간편한 증상 기록

사용자가 불편한 증상을 선택하고, 증상의 정도와 지속 기간 등을 간단히 기록.

식사 사진도 선택적으로 등록해 음식의 영양소를 분석합니다

② 캐릭터 상태 반영

기록된 증상의 종류와 심각도를 바탕으로 현재 건강 상태를 1~5단계 캐릭터로 표현합니다. 상태가 좋지 않을수록 캐릭터의 표정과 모습이 달라져 자신의 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

*소제목 정도만 언급하고, 아래 줄글 설명은 ppt에만 적든가

③ 상태에 따른 맞춤형 알림

캐릭터 상태와 투약 상황에 따라 증상 체크 알림의 빈도를 조절합니다. 상태가 좋지 않거나 위험 증상이 나타나면 추가 안내를 제공합니다.

~~**④ 위험 증상 대응**~~

~~위험 증상이 확인되면 점수와 관계없이 즉시 경고 화면을 표시하고, 의료기관의 도움을 받도록 안내합니다~~.

⑤ 병원 공유 리포트

일정 기간의 증상 변화와 생활습관 기록을 요약해 리포트로 제공합니다. 사용자가 동의하면 의료진과 공유해 진료에 참고할 수 있습니다.

① 증상 체크 (1분)

입력 부담을 줄이려고 **불편한 곳(범주)만 고르면 세부 항목이 열리는** 방식입니다.

범주	세부 항목	점수에 들어가는 증상
속이 불편해요	메스껍거나 울렁거려요	메스꺼움
	평소보다 토하는 일이 잦아졌어요	구토 (2배)
	더부룩하거나 소화가 안 돼요 / 트림이 잦아요	복부 불편
	신물이 올라오거나 가슴이 쓰려요	속쓰림
배가 불편해요	가스가 차요 / 배가 빵빵해요	복부 불편
화장실 습관이 달라졌어요	묽은 변·설사	설사
	변보기 어려움	변비
오늘따라 힘이 없어요	쉽게 피곤해요 / 일어설 때 어지러워요	피로·어지러움
가려워요	발진·가려움 / 주사 부위가 붉고 부음	점수 없이 리포트에 기록 (두드러기+숨참·얼굴 붓기는 위험 증상)
그 밖의 변화	자유 입력	점수 없이 리포트에 기록

체크한 증상마다 **상세 문진** 한 번으로 점수가 정해집니다.

질문	답 → 점수
얼마나 불편했나요?	체크 안 함 0 / 가벼워요 1 / 보통이에요(일상에 조금 지장) 2 / 심해요(일상이 어려움) 3
식사나 물은 괜찮았나요?	평소처럼 0 / 평소보다 어려웠어요 2 / 거의 못 먹고 마셨어요 3 → **"물을 못 마심" 점수 (2배)**

질문	답 → 점수
언제부터였나요?	“일주일 이상” 또는 “나아졌다 다시 나타나요” → 점수는 그대로, **리포트에 '지속 증상'으로 표시** + 챗봇 안내

그 밖에 짧은 질문 2개(단백질을 먹은 끼니 수 0~3, 근력 미션 했는지)와, **원하는 날에만** 식사 사진을 올립니다. 사진은 AI가 “기름짐·매움·과식”을 표시하고 사용자는 확인만 합니다. 어떤 음식 뒤에 증상이 오는지 찾는 용도입니다.

② 캐릭터 상태 계산

1단계. 오늘의 증상 점수: 8개 증상(메스꺼움, 설사, 변비, 복부 불편, 속쓰림, 피로·어지러움, 구토, 물을 못 마심) 점수를 더합니다. **구토와 물 못 마심은 2배**(탈수 위험). 최고 30점입니다.

2단계. 오늘의 컨디션

증상 점수	0~2	3~5	6~9	10~14	15 이상
오늘 컨디션	5 (아주 좋음)	4	3 (보통)	2	1 (최악)

- 구토나 물 못 마심이 2 이상이면 컨디션은 **최대 2**로 둡니다.

3단계. 캐릭터 상태 = 오늘 컨디션 30% + 어제까지의 상태 70%

- 하루 아팠다고 확 쓰러지지 않고, 며칠 계속 안 좋으면 서서히 내려갑니다.
- 기록하지 않은 날은 어제 상태를 그대로 둡니다.

> **예시:** 어제 4단계 → 오늘 구토 2, 물 못 마심 2
> 증상 점수 8점 → 컨디션 3이지만 구토가 2 이상이라 **2로 제한**
> 캐릭터 = 2 × 0.3 + 4 × 0.7 = 3.4 → **3단계**

③ 상태에 따라 달라지는 알림 (Patient journey–adaptive care)

상황	체크 알림
이번 주에 용량을 올림	**하루 2번** (부작용은 주로 증량 시기에 생김)
캐릭터 5단계	주 2번
캐릭터 4단계	주 3번
캐릭터 3단계	이틀에 1번
캐릭터 2단계 이하	매일 + 챗봇이 먼저 말 걸기
위험 증상 체크	**즉시** 경고 화면

알림이 없는 날에도 언제든 기록할 수 있습니다.

④ 앱이 반응하는 순간

상황	반응
위험 증상 (아래 5개 중 하나라도)	**바로 경고 화면 + 병원 안내.** 점수와 상관없음
캐릭터 2단계 이하 이틀 연속 / 1단계 / 3일 만에 2단계 이상 하락	챗봇이 먼저 말을 겁니다
오늘 컨디션 1~2	근력 미션 쉬기

위험 증상 5개: 등으로 뻗치는 심한 복통이 계속됨 / 하루 넘게 물·음식을 거의 못 넘기고 소변이 줄었음 / 오른쪽 윗배 통증과 열, 또는 눈·피부가 노래짐 / 두드러기·숨참·얼굴 붓기 / (당뇨약 병용자만) 식은땀·떨림

⑤ 병원에 가져가는 4주 리포트

증상별 평균, 가장 힘들었던 날, 지속 증상, 용량 올린 날, 단백질 끼니, 근력 미션 횟수. 환자가 동의하면 병원 대시보드로도 보냅니다.

4-4. 약을 끊을 때 [..?] : 약을 끊었어요 기록. 시작 체중, 투약 중 가장 낮았던 체중(일주일 평균), 마지막 주사일.을 앱은 기억할 것입니다. 이것이 앱 기능의 전환점입니다. 이제 이앱은 다음 페이스로 넘어갑니다.

~~왜 끊은 뒤를 따로 관리해야 할까~~

- ~~마운자로로 감량한 뒤 약을 끊은 그룹은 1년 동안 체중이 **14.0% 다시 늘었고**, 계속 맞은 그룹은 5.5% 더 빠졌습니다. 감량분의 80% 이상을 지킨 사람은 끊은 그룹 16.6%, 계속 맞은 그룹 89.5%였습니다. [8]~~
- ~~2026년 BMJ 메타분석에 따르면 신약을 끊은 뒤 체중은 **한 달에 약 0.8kg씩** 돌아오고, 이는 식이·운동으로 뺀 뒤의 요요보다 **한 달 0.3kg 더 빠릅니다**. 혈압·혈당 같은 대사 지표도 약 1.4년이면 원래대로 돌아갑니다. [9]~~
- ~~체중이 돌아온 만큼 허리둘레와 혈압도 함께 돌아옵니다. 감량분의 25% 미만만 돌아온 사람도 수축기 혈압이 평균 6.8mmHg 올랐습니다. [10]~~
- ~~그런데 실제로 1년 넘게 약을 이어가는 사람은 많지 않습니다. 미국 실사용 자료에서 1년 지속률은 24.5~60.9%입니다. [11] 대부분이 비급여로 자기 돈을 내는 한국에서는 **끊는 사람이 더 많을 가능성**이 큽니다.~~

> ~~그래서 GLIP은 약을 끊는 순간을 **관리의 끝이 아니라, 두 번째 관리의 시작**으로 봅니다.~~

~~끊는 이유를 고릅니다~~

이유	앱 안내
부작용	의사와 용량 조절 상담 안내
비용	저용량 유지 시 비용 비교 (결정은 의사와)
목표 달성 / 기타	바로 유지 관리 시작

~~앱이 기억하는 숫자:~~ ~~시작 체중, 투약 중 가장 낮았던 체중(일주일 평균), 마지막 주사일. 시작 체중과 가장 낮았던 체중의 차이가 **"뺀 체중"**입니다.~~

~~중단 후 4단계 (52주)~~

단계	시기	하는 일	근거
0. 중단 준비	마지막 주사 2~4주 전	기준 체중·허리둘레 기록, 목표 범위(±2.3kg) 정하기, 유지 방법(저용량 유지 등)은 의사와 결정, 식사 사진 연습	5mg 저용량 유지 시 재증가 약 7% vs 위약 15.2% [20] → 선택지는 의사와
1. 약효 퇴장기	0~4주	배고픔 예보, 단백질 먼저 먹기, 매일 체중, 챗봇 주 2회	마운자로 반감기 약 5일, 약 30일이면 몸에서 빠짐 [21]
2. 적응기	5~16주	체중 신호등 본격 운영, 활동 목표 단계적 상향, 코칭 주 1회	중단 후 4개월 구조화 프로그램 파일럿 [22]
3. 유지기	17~52주	코칭 월 1회	NICE(2025): 중단 후 **최소 1년** 지원 [23] · 미국 가이드라인: 1년 이상 유지 프로그램 [24] · 임상시험도 52주 단위
52주 이후	-	**자율 유지 모드** (월 1회 신호등은 계속)	재증가는 약 1.5년까지 이어짐 [9] → 완전 졸업 대신 가볍게 지켜보기

4-5. 약을 끊은 뒤: 생활습관 + 체중 관리

1 생활습관(내가 조절할 수 있는 것)을, 2 **체중**을 관리함. 생활습관은 캐릭터가, 체중 위험도는 신호등으로 보여줌

1 생활기록: 끼니마다 식사 사진(AI가 단백질·채소·정제 탄수화물 여부를 표시, 사용자가 확인), 식전 배고픔(0~10), 물 목표 달성 여부, 활동 시간(자동), ~~근력 미션~~

2 **체중:** 체중을 기록함. 일주일 평균 체중이 "뺀 체중"의 몇 %만큼 돌아왔는지 보여줌. 단 수치로 보여주는 것이 아니라 range를 3개(25%/ 25-50% / 50% 이상) 로 나누어서 제시함.(주1회) 빨간색 노란색 초록색

~~① 생활습관 점수 → 캐릭터~~

~~**매일 기록:** 끼니마다 식사 사진(AI가 단백질·채소·정제 탄수화물 여부를 표시, 사용자가 확인), 식전 배고픔(0~10), 물 목표 달성 여부, 활동 시간(자동), 근력 미션~~

항목	기준	점수
단백질	단백질이 있는 끼니 1개당 10점	최대 30
규칙적인 끼니	3끼 기록 20점, 2끼 10점	최대 20
채소	하루 중 한 끼라도	10
저GI	정제 탄수화물·단 음료 없음	10
수분	물 목표 달성	10
활동	오늘 활동 목표 또는 근력 미션	10
기록	2끼 이상 사진 기록	10
합계		**100**

- ~~신장질환자는 단백질 항목을 빼고 70점을 100점으로 환산합니다.~~
- **활동 목표:** ~~끊은 뒤 1~4주 주 150분 → 5~8주 주 200분 → 9주부터 주 250분 (유지기 권고 주 200~300분 [24])~~

하루 점수	80 이상	60~79	40~59	20~39	20 미만
하루 단계	5	4	3	2	1

캐릭터 상태 = 오늘 단계 20% + 어제까지의 상태 80% (습관은 천천히 바뀌니 더 천천히 움직이게)

~~② 체중을 기록하게 하여서 이를 보여줍니다. 신호등 (주 1회)~~

~~일주일 평균 체중이 "뺀 체중"의 몇 %만큼 돌아왔는지 봅니다.~~

> ~~**예시:** 시작 100kg → 가장 낮을 때 80kg (뺀 체중 20kg)~~
> ~~지금 일주일 평균 86kg → 6kg 돌아옴 → **30%** → **노랑**~~

신호	기준	앱 반응
🟢 초록	25% 미만	유지 관리 계속
🟡 노랑	25~50%, **또는** 최근 한 달에 0.8kg 넘게 증가	**"2주 리셋"**: 매일 체중, 정해진 식단 템플릿, 코칭 주 2회
🔴 빨강	50% 이상, **또는** 노랑이 4주 계속	**의사 상담 권고 + 병원 리포트**

- ~~뺀 체중이 시작 체중의 5% 미만이면 kg으로 봅니다: 1.4kg 이상 늘면 노랑, 2.3kg 이상이면 빨강~~
- ~~나빠질 때는 바로 바꾸고, 좋아질 때는 2주 연속 좋아야 바꿉니다.~~
- ~~기준은 의사가 환자별로 조정할 수 있습니다.~~

- ~~초록이 "안전"이라는 뜻은 아닙니다. 25% 미만만 돌아와도 혈압은 오르기 시작하므로 [10], 초록에서도 생활습관 관리는 계속합니다.~~

~~③ 챗봇이 말을 거는 순간~~

- ~~캐릭터 2단계 이하 3일 연속~~
- ~~신호등 색이 바뀜~~
- ~~배고픔 점수가 2주 사이 평균 2점 이상 오름 (가설 단계)~~
- ~~3일 동안 기록이 없으면 가벼운 알림만 (경고 아님)~~

~~④ 한 달에 한 번~~

~~즐자로 허리들레 재기, 30초 의자 일어서기 횟수 세기 (근력 확인)~~

~~4-6. 병원 연결~~

- ~~빨간불 환자는 병원 대시보드에 리포트(체중 변화, 허리둘레, 생활습관 추세, 근력 테스트)와 함께 **면저** 표시됩니다.~~
- ~~대면 진료에서 의사가 재투여, 저용량 유지, 다른 치료 중에서 결정합니다.~~
- ~~다시 처방받으면 앱은 처방 중 단계로 돌아가고, 그때 체중이 새 시작 체중이 됩니다.~~

4-7. 새싹과 꾸미기 상점 (모든 단계 공통)

1 사용자가 건강 관리 기록을 남기면 새싹(캐시)을 지급한다.

2 꾸미기 상점에서 새싹을 쓰면 캐릭터 꾸미기 아이템을 살 수 있다.

3 상점에서는 유료 꾸미기 아이템도 판매.

이로서 꾸미기 기능을 활성화하여 유저의 즐거움을 높이고, 수익성 확보 건강 관리의 지속성을 보상합니다.

~~① 새싹 버는 법: 기록 행동으로만~~

행동	새싹
체크리스트 제출	10
식사 사진 (하루 최대 3장)	장당 5
근력 미션	10
주 1회 체중 측정	10

~~② 상점은 두 칸입니다~~

칸	얻는 법	예시
새싹 상점	새싹으로만 교환	일반 50(1~2일) · 레어 300(1~2주) · 시즌 1,000(약 1개월)
비매품	꾸준함 달성으로만 (돈·새싹으로 못 삼)	"30일 연속 기록" 배지, "약 끊고 30일 완주" 액자, "52주 완주" 배경
프리미엄 꾸미기	유료 구매	캐릭터 스킨, 배경 테마, 시즌 패스

~~건강 소품도 넣습니다: 물병, 덤벨, 운동화처럼 귀여우면서 메시지가 담긴 아이템.~~

~~③ 상점 규칙~~

- ~~**건강 기능은 전부 무료**입니다. 유료 아이템은 순수하게 꾸미기만 바꿉니다.~~
- ~~확률형 뽑기는 없습니다.~~
- ~~캐릭터 1~2단계(몸이 안 좋은 상태)일 때는 구매 권유를 띄우지 않습니다.~~
- ~~체형이나 체중과 연결된 아이템은 없습니다("날씬해지는 옷" 금지). 모든 옷은 모든 체형에 맞게 그립니다.~~
- ~~특별 아이템은 체중 결과가 아니라 **꾸준함**으로만 받습니다.~~

~~4-8. 안전 규칙 (모든 단계 공통)~~

- ~~**위험 증상 판정은 AI가 아니라 정해진 규칙**으로 즉시 합니다.~~
- ~~**챗봇은 검수된 내용만** 꺼내서 답합니다(약 설명서, 증상별 팁).~~
- ~~진단, 투약 중단·건너뛰기, 용량 조언은 하지 않고 "의사와 상의하세요" + 리포트 공유로 끝냅니다.~~
- ~~**AI 사진 분석은 칼로리를 계산하지 않습니다.** 범주만 표시하고, 최종 확인은 사용자가 합니다.~~
- ~~식사 사진 분석은 자체 모델 개발이 아니라 **VLM API 호출**로 구현합니다.~~

~~4-9. 숫자의 출처 (발표 대비)~~

숫자	근거
구토·물 못 마심 2배	마운자로 허가사항의 탈수·급성 콩팥 손상 경고 [7]
용량 올린 주 알림 하루 2번	SURMOUNT-1: 부작용은 주로 증량 시기에 발생 [6]
신호등 25% / 50%	재증가 비율이 클수록 허리둘레·혈압이 더 나빠짐 [10] / 저용량 유지 연구의 재투약 기준 [20]
한 달 0.8kg	BMJ 2026 평균 재증가 속도 [9]
1.4kg / 2.3kg, 신호등 방식	STOP Regain 연구의 3파운드/5파운드 구간과 색깔 구역 [25]
첫 30일 집중	마운자로 반감기 약 5일, 약 30일이면 몸에서 빠짐 [21]
52주	NICE QS212(2025) 중단 후 최소 1년 지원 [23], 미국 AHA/ACC/TOS 가이드라인 1년 이상 [24]
활동 150 → 250분	미국 가이드라인 유지기 주 200~300분 [24]
단백질 끼니, 근력운동	4개 학회 공동 권고문 (단백질 1.2~1.6g/kg 또는 하루 80~120g + 근력운동) [26]
캐릭터와 꾸미기	게임화 메타분석: 피드백과 아바타가 가장 효과적인 요소 [19]
증상 구간, 30%·20% 반영 비율, 생활습관 배점, 새싹 가격	**우리가 정한 초기값 → 사용자 데이터로 보정 예정**

> **발표용 한 줄 요약**
> "처방 중에는 부작용을 잡아 위험 신호를 놓치지 않게 돕고, 끊은 뒤에는 생활습관과 체중 신호등으로 요요를 일찍 잡아 필요하면 다시 병원으로 연결합니다. 그리고 그 모든 기록은, 결과와 상관없이 새싹으로 보상합니다."

→ 비슷한 앱은 이미 있지 않을까요?

---

5. Competitor Analyses

(1) 무엇에 집중하나

	GLIP	Noom GLP-1 Companion	노보핏케어 (노보 노디스크 × 카카오 파스타)	삐약	필라이즈
Medication Specificity (GLP-1 투약·부작용 관리)	🟦 High	🟦 High	🟦 High	🟦 High	⬜ Low
Self-care Specificity (정서적 동기, 체중 외 지표)	🟦 High	⬜ Low	⬜ Low	⬜ Low	⬜ Low
Post-discontinuation Care (중단 후 요요 관리)	🟦 High	🟦 High (미국)	⬜ Low	⬜ Low	⬜ Low
Clinician Connection (국내 병원 리포트·재연결)	🟦 High	⬜ Low (국내 없음)	⬜ Low	⬜ Low	⬜ Low

> **"In Korea, every app tracks the drug or the diet. GLIP cares for the person taking it — during and after the drug."**

(2) 서비스 비교

	GLIP	Noom GLP-1 Companion	노보핏케어	삐약	필라이즈
Product / Service	Avatar-based self-care for GLP-1 users, during and after the drug	GLP-1 behavior-change coaching	Pharma patient-support program for Wegovy	GLP-1 injection log & community	AI diet, nutrition & supplement coach
Target audience	GLP-1 users in Korea (Wegovy + Mounjaro), **on-drug & post-discontinuation**	General GLP-1 users (US)	**Wegovy-only** patients (KR)	General diet-injection users (KR)	General adults (KR)
Pricing	Health features free · clinic monthly fee (B2B) · premium cosmetics	Free (since 2026.06)	Free for Wegovy patients (product-box code)	Free (확인 필요)	Freemium (Plus 6 months ₩46,900)
Strengths	Avatar-mediated self-awareness, journey-adaptive check-ins, **clinic report & re-connection**	Protein·muscle·side-effect tools, post-GLP-1 maintenance data	Official pharma info, genuine-product check, Kakao reach	Domestic community, hospital & pharmacy info	Large nutrition DB, supplement AI

	GLIP	Noom GLP-1 Companion	노보핏케어	삐약	필라이즈
Weakness	Needs clinical validation data	**US-focused**, no Korean clinic link	**Wegovy only** (excludes Mounjaro, the market leader)	Logging only, no danger-signal detection	No GLP-1 context
Key advantage	**Korea's only care that continues after stopping and connects back to the clinic, regardless of drug brand**	Brand & free scale	Manufacturer credibility	Community	Nutrition coverage

(3) Why Should We Use This Service?

Criteria	Noom	노보핏케어	삐약	필라이즈	**GLIP**
GLP-1 Dose Reminder & Log	⭕	⭕	⭕	❌	⭕
Brand-neutral (Wegovy + Mounjaro)	⭕	❌	⭕	❌	⭕
Side-effect Danger-signal Detection	△	△	❌	❌	⭕
Health-status Score (not weight)	△	❌	❌	△	⭕
Character-based Emotional Motivation	❌	❌	? (확인 필요)	△	⭕
Post-discontinuation Care	⭕ (미국)	❌	❌	❌	⭕
Clinician Report (진료용 요약 공유)	△	❌	❌	❌	⭕

- △ Noom 부작용: 일반적인 부작용 관리는 있으나 위험 신호 판정은 아님 / Noom 리포트: 미국 의료진용 무료 버전은 있으나 국내 병원 연결 없음
- △ 노보핏케어: 안전 사용 안내 + 용량 오남용 방지 '정보 제공' 수준
- △ 필라이즈: 영양·혈당 등 체중 외 지표 있음 (캐릭터 돌봄은 아님)
- ❌ 표시는 공개된 기능 기준입니다. 발표 전 각 앱 최신 버전으로 한 번 더 확인합니다.

기존 서비스가 약·식단·체중을 기록하는 데 초점을 맞춘다면, GLIP은 사용자가 자기 몸의 신호를 알아차리고, 약을 끊은 뒤에도 관리를 이어가고, 필요할 때 병원으로 돌아가도록 돕습니다. Noom의 중단 후 데이터는 이 방향이 맞다는 신호이고, 국내에는 아직 이 자리를 채운 서비스가 없습니다.

→ 그럼 이 자리는 돈으로 얼마일까요?

6. TAM / SAM / SOM

GLIP은 돈을 내는 쪽이 둘입니다. **환자(B2C)**와 **병원(B2B)**. 그래서 시장도 두 쪽으로 나눠 계산합니다.

6-1. 무엇을 세나

단계	환자 쪽 (B2C)	병원 쪽 (B2B)
TAM (전체 시장)	국내 GLP-1 비만약 **투약 중인 사람 + 최근 1년 안에 끊은 사람**	GLP-1 비만약을 공급받은 **의원 전체**
SAM (우리가 닿을 수 있는 시장)	그중 **수도권** 사용자 (첫 영업 지역)	그중 **수도권** 의원
SOM (3년 안에 실제로 얻을 시장)	계약 병원의 환자 중 앱에 가입한 사람	3년 안에 유료 계약한 의원

매출 공식

- 병원 매출 = 계약 의원 수 × 월 이용료 × 12개월
- 환자 매출 = 가입자 수 × 유료 구매 비율 × 1인 연간 구매액
- 제약사 분석 서비스는 확장 단계라 3년 수치에 넣지 않습니다.
- 매출 비율은 미리 정하지 않고, **계산 결과로 나온 값**을 씁니다.

6-2. 사람 수 계산 (기본 시나리오)

① 지금 약을 쓰는 사람 ≈ 48만 명

- 2026년 2분기 두 약 매출 5,342억 원 → 한 달 약 1,781억 원 [15]
- 한 사람의 한 달 약값을 37만 원으로 보면(마운자로 시중가 약 33만 원 수준 [27], 위고비 21~42만 원 [28], 고용량일수록 비쌈) → 1,781억 ÷ 37만 ≈ **48.1만 명**
- 교차 확인: 마운자로만 2026년 8월 한 달 처방전 약 40만 건 [29] → 위고비를 더하면 비슷한 규모

② 1년 동안 약을 끊는 사람 ≈ 64만 명

- 평균 투약 기간을 9개월로 가정 (미국 실사용 1년 지속률 24.5~60.9% [11], 비급여인 한국은 더 짧을 수 있음)
- 48.1만 × 12 ÷ 9 ≈ **64.2만 명**

③ 환자 쪽 TAM = 48.1만 + 64.2만 ≈ 112만 명

④ **의원 수 = 1만 6,047곳** (위고비 공급 의원 [16], 마운자로 1만 4,525곳과 대부분 겹친다고 보고 큰 쪽 사용)

6-3. 시나리오별 결과

항목	보수	**기본**	낙관
지금 약을 쓰는 사람	39.6만 명	**48.1만 명**	59.4만 명
1년 동안 끊는 사람	39.6만 명	**64.2만 명**	118.7만 명
환자 TAM / SAM	79.1만 / 52.1만 명	**112.3만 / 73.9만 명**	178.1만 / 117.2만 명
의원 TAM / SAM	1만 6,047 / 8,922곳	**1만 6,047 / 8,922곳**	1만 6,047 / 8,922곳
3년 차 계약 의원 (SOM)	89곳	**268곳**	535곳
3년 차 앱 가입자 (SOM)	880명	**5,619명**	2만 3,761명
TAM (연 매출)	97.6억 원	**194.5억 원**	310.9억 원

항목	보수	**기본**	낙관
SAM (연 매출)	54.4억 원	**108.6억 원**	175.1억 원
SOM (3년 차 연 매출)	0.5억 원	**3.2억 원**	9.9억 원
매출 구성 (TAM 기준)	병원 98.6% / 환자 1.4%	**병원 98.0% / 환자 2.0%**	병원 92.9% / 환자 7.1%

6-4. 사용한 숫자와 가정

[근거]는 공개 자료, [가정]은 우리가 정한 값입니다. 가정은 파일럿에서 실제 값으로 바꿉니다.

항목	보수	기본	낙관	출처
월 약 매출	1,781억 원	1,781억 원	1,781억 원	[근거] 아이큐비아 2026년 2분기 [15]
1인 월 약값	45만 원	37만 원	30만 원	[가정] 시중가 범위 [27][28]
평균 투약 기간	12개월	9개월	6개월	[가정] 미국 1년 지속률 24.5~60.9% [11]
의원 수	1만 6,047곳	1만 6,047곳	1만 6,047곳	[근거] 심평원 공급 자료 [16]
수도권 비중 (환자)	65.8%	65.8%	65.8%	[근거] 비만약 공급량의 수도권 비중 [30]
수도권 비중 (의원)	55.6%	55.6%	55.6%	[근거] 수도권 근무 의사 비중으로 대신함 [31]
3년 안에 계약하는 비율 (수도권 의원 중)	1%	3%	6%	[가정] 병원에 무료였던 똑닥도 약 6년에 1만 곳 [32] → 유료 신규 서비스는 훨씬 낮게
의원 월 이용료	5만 원	9.9만 원	15만 원	[가정] 기존 병의원 CRM 월 1만~20만 원 [33]
계약 병원 환자 중 앱 가입률	20%	30%	40%	[가정] 파일럿에서 측정
유료 구매 비율	2.1%	2.9%	6.2%	[근거] 구독 앱 설치→결제 전환율: 무료 체험형 2.1%, 헬스·피트니스 중간값 2.9%, 상위 25% 6.2% 이상 [34]
1인 연간 꾸미기 구매액	8천 원	1.2만 원	2만 원	[가정] 시즌 아이템 연 3~4회

6-5. 이 숫자가 말해주는 것

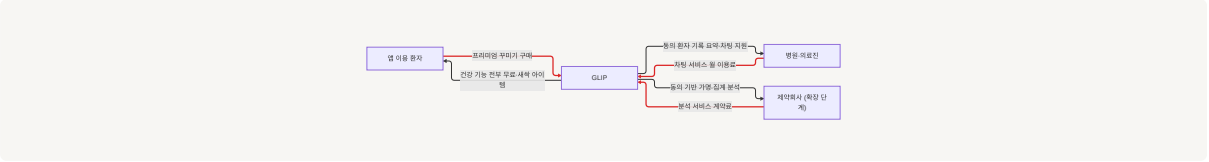
1. **돈은 병원에서 나옵니다.** 어느 시나리오에서도 병원 매출이 93~99%입니다. 꾸미기 판매로는 매출을 받칠 수 없습니다.
2. **병원 입장에서 부담이 작습니다.** 의원 한 곳당 지금 약을 쓰는 환자는 평균 약 30명입니다. 월 9.9만 원이면 환자 1명당 월 약 3,300원, **한 달 약값의 1% 미만**입니다.
3. **시장은 계속 커집니다.** 마운자로 처방은 10개월 만에 18배가 됐고 [1], 약을 쓰는 사람이 늘수록 끊는 사람도 함께 늘어납니다.
4. **더 큰 기회는 3년 수치 밖에 있습니다.** 비대면진료 시행(2026.12), 경구 GLP-1 같은 새 약, 제약사 분석 서비스는 확장 단계로 남겨 두었습니다.

> 발표용 한 줄: **"공개 자료로 계산한 국내 시장은 연 194억 원(기본), 3년 차 목표는 수도권 의원 268곳, 연 3.2억 원입니다."**

→ 그럼 어떻게 돈을 벌까요?

7. Business Model

[이미지: 수익 흐름도]



7-1. 수익원

수익원	누가 내나	무엇을 파나	과금	매출 비중 (6장 계산 결과, TAM 기준)
병원 차팅 서비스 (핵심)	의원	동의 환자의 4주 리포트, 빨간불 우선 표시 대시보드, 차팅용 요약 출력	기관당 월 정액 (기본 9.9만 원)	**약 98%**
프리미엄 꾸미기 (보조)	환자	캐릭터 스킨, 배경 테마, 시즌 패스	건별 구매	**약 2%**
제약사 분석 서비스 (확장 단계)	제약사	환자 동의 기반 가명·집계 분석 보고서	계약	3년 수치 제외

7-2. 이전 안에서 바뀐 점

수익원	이전 안	이번 안	이유
환자 꾸미기	38%	약 2%	공개 전환율로 계산하면 이 이상 나오기 어려움 → **매출원이 아니라 계속 쓰게 만드는 장치**로 둠
의료진 차팅 서비스	47.5%	약 98%	실제로 돈을 낼 수 있는 쪽. 환자 1명당 월 약값의 1% 미만
병원 광고	9.5%	**삭제**	앱에서 특정 병원을 홍보하면 의료법의 환자 유인 문제가 생길 수 있음
제약사 분석	5%	확장 단계	데이터가 쌓이고 동의·가명처리 체계를 갖춘 뒤 시작

7-3. 원칙

- **건강 기능은 전부 무료.** 돈이 없어서 위험 신호를 놓치는 일은 없어야 합니다.
- **병원 이용료는 기관 단위 정액.** 환자 한 명을 보내줄 때마다 돈을 받는 구조가 아니므로 환자 소개·알선 문제를 피합니다.
- **꾸미기는 순수 꾸미기.** 뽑기 없음, 아플 때 구매 권유 없음, 몸·체중과 연결된 아이템 없음.
- **데이터는 동의한 경우에만, 가명·집계 형태로만.**

→ 이 순서대로 만들어 갑니다.

8. Business Roadmap

STEP 1 · 0~3개월 · MVP 출시와 사용자 검증 (B2C)

- 처방 중: 범주형 증상 체크 → 캐릭터 상태 → 위험 증상 경고 → 챗봇
- 중단 후: 생활습관 점수, 체중 신호등, 52주 4단계 관리 (**규칙 기반으로 구현**)
- 식사 사진 분석 (VLM API), 새싹 상점
- SNS·다이어트 커뮤니티로 초기 사용자 확보
- 측정: 4주 체크 지속률, 체크 완료율, 위험 증상 → 병원 안내 클릭률

STEP 2 · 3~6개월 · 병원 파일럿 (B2B)

- 수도권 비만 진료 의원 5~10곳과 무료 파일럿
- 4주 리포트·빨간불 대시보드를 실제 진료에 사용
- 측정: 의사가 본 리포트 비율, 진료 시간 변화, 월 이용료 지불 의향, 앱 가입률

STEP 3 · 6~12개월 · 유료 전환

- 파일럿 병원 유료 전환, 수도권 의원으로 확대 (1년 차 목표 30곳)
- 프리미엄 꾸미기 출시
- 비대면진료 시행(2026.12)에 맞춘 진료 사이 리포트 연동 검토
- 측정: 52주 프로그램 유지율, 노랑불 → 초록불 회복률

STEP 4 · 12~36개월 · 데이터 기반 확장

- 3년 차 목표: 수도권 의원 268곳 (기본 시나리오)
- 쌓인 기록으로 **요요 위험 예측 모델** 검증 (9장 Further work)
- 동의 기반 가명·집계 데이터로 제약사 분석 서비스 시작
- 경구 GLP-1 등 새 약과 수도권 밖 지역으로 확장

연차	계약 의원 (기본 목표)	병원 매출 (연)
1년 차	30곳	약 0.36억 원
2년 차	120곳	약 1.43억 원
3년 차	268곳	약 3.18억 원

---

9. Results of Initial Product & Further Work

1. User Validation

- GLP-1 사용자 인터뷰로 “self-care 공백”이 실제로 있는지 확인
- 아바타가 자기 인식을 바꾸는지 평가 (캐릭터를 본 뒤 위험 증상을 더 일찍 알리는가)
- 체크 지속률, 기록 완료율, 52주 프로그램 유지율 측정

2. Clinical Validation

- 의료진 자문으로 증상 체크리스트, 위험 증상 5개, 신호등 기준(25%/50%) 검증
- 4주 리포트가 진료에 실제로 쓸모 있는지 평가
- 위험 증상이 생겼을 때 적절한 진료로 이어지는지 확인

- 증상 구간, 반영 비율(30%·20%), 생활습관 배점을 실제 데이터로 보정

3. Business Validation

- 의원 원장 인터뷰: 월 이용료 지불 의향과 적정 가격
- 파일럿으로 6장의 가정값(가입률, 계약 비율, 구매 비율)을 실제 값으로 교체
- 고객 확보 비용과 운영 비용(VLM API 호출 비용 포함) 산정

4. Further Work: 요요 위험 예측 모델

- 지금은 **규칙 기반 신호등**으로 요요를 잡습니다. 이것만으로도 체중이 돌아오기 시작하는 순간을 알 수 있습니다.
- 다음 단계는 **노랑불이 켜지기 전에** 미리 알려주는 예측 모델입니다(배고픔 점수 변화, 기록 빈도, 생활습관 점수 추세 등).
- 예측 모델은 충분한 종단 데이터가 쌓인 뒤 타당성을 검증합니다. 데이터 없이 만든 예측은 믿을 수 없기 때문입니다.
- 참고: 중단 후 지원 프로그램이 재증가를 늦추는지는 연구마다 결과가 엇갈립니다(BMJ 2026에서는 뚜렷한 효과 없음 [9], Noom 관찰 분석에서는 효과 시사 [18]). GLIP은 **재증가를 일찍 알아채 병원으로 다시 연결하는 것**을 1차 목표로 둡니다.

출처

국내 처방·시장

- [1] 데일리팜, “[국감] 위고비·마운자로-마약류 비만약, DUR 사각지대” (2026.10.13, 서영석 의원실·심평원 자료) https://dailypharm.com/user/news/343352
- [2] 한국경제, 국정감사 비만치료제 처방 실태 (2025.10.16) https://www.hankyung.com/article/2025101617277
- [3] 세계일보, 위고비 누적 처방 122만 건·20~30대 46.4% (2026.07.29) https://www.segye.com/newsView/20260729502434
- [4] 데일리팜, “[국감] 위고비·마운자로 처방 후 안과·소화기 질환 1.3만명” (2026.10.14) https://dailypharm.com/user/news/343393
- [5] 데일리팜, “[국감] 서영석 ‘GLP-1 오남용우려의약품 지정 서둘러야’” (2026.10.13) https://dailypharm.com/user/news/343368
- [15] 데일리팜, 아이큐비아 분기 매출 (2026.09.01) https://dailypharm.com/user/news/341968
- [16] 메디게이트뉴스, 남인순 의원실·심평원 의료기관 공급 자료 (2026.10.09) https://www.medigatenews.com/news/3162341310
- [17] 쿠키뉴스, 대한비만학회 ‘2025 비만 팩트시트’ (2025.09.04) https://www.kukinews.com/article/view/kuk202509040218
- [27] SBS Biz, 마운자로 시중가·위고비 가격 인하 https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000258476
- [28] 뱅크샐러드, 2026 위고비 가격 https://www.banksalad.com/articles/위고비가격-보험-처방병원
- [29] 마운자로 2026년 8월 처방전 40만 4,602건 (2026 국정감사 심평원 자료) — 스트레이트뉴스 https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=313031 · 약사공론 https://www.kpanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=546627

- [30] KNN, 비만치료제 수도권 공급 65.8% (서미화 의원실) https://news.knn.co.kr/news/article_sns/849
- [31] 노컷뉴스, 제2차 보건의료인력 실태조사 (수도권 근무 의사 55.6%) https://nocutnews.co.kr/news/6584425
- [32] 데일리안, 똑닥 유료화·제휴 병원 1만여 곳 (2023 국감) https://www.dailian.co.kr/news/view/1282325
- [33] 메디칼타임즈, 의사랑CRM 가격제 (월 1만~20만 원) https://www.medicaltimes.com/Main/view.html?ID=1120879

중단 후 사례·사후관리 비판 보도 (2-3)

- [35] 레이디경향, "'위고비 요요 속도 4배 빠르다' 중단 후 더 찌는 과학적 이유" (2026.02.06) https://lady.khan.co.kr/health/article/202602061025001
- [36] 헤럴드경제, "'10kg 감량' 빠니보틀, 위고비 끊자 요요" (2026.05.10) https://www.heraldk.com/article/2026051018220960365
- [37] "8kg 빠져 위고비 끊자 다시 쪘다…요요 막는법 3가지" [바디플랜] (2026.02.20) https://v.daum.net/v/20260220100638390
- [38] 머니투데이방송(MTN), 대한비만학회 허양임 홍보이사 인터뷰 (2026.10.01) https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026100116255850501
- [39] 파이낸셜뉴스, "GLP-1 비만치료제 처방 환경 도마 위" — 박정환 한양대병원 교수 (2026.09.11) https://www.fnnews.com/news/202609110923344528
- [40] 머니투데이, "비만약 '오남용 우려약' 지정 임박…'국가적 관리체계가 우선' 목소리도" (2026.05.28) https://www.mt.co.kr/thebio/2026/05/28/2026052816165217799

해외 시장·벤치마크

- [11] 미국 GLP-1 1년 지속률: Marshall et al., JMCP 2026 (60.9%), Xie et al., JAMA Netw Open 2026 (24.5%) — 정리 https://therxindex.com/guides/glp-1-adherence-statistics/ / Prime Therapeutics (2025) https://www.biospace.com/press-releases/prime-therapeutics-leading-research-shows-only-1-in-12-remain-on-a-glp-1-drug-for-obesity-at-three-years
- [12] J.P. Morgan https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/current-events/obesity-drugs
- [13] Morgan Stanley https://www.morganstanley.com/ideas/obesity-drugs-market-expanded-opportunity
- [14] Goldman Sachs https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-anti-obesity-drug-market-may-prove-smaller-than-expected
- [18] Noom, GLP-1 중단 후 관찰 분석 (2026.06.24) https://www.noom.com/in-the-news/noom-members-regained-3x-less-of-their-lost-weight-after-stopping-glp-1s-new-analyses-show/
- [34] RevenueCat, State of Subscription Apps 2026 https://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps — 카테고리별 수치 정리 https://thesocialoutline.com/blog/download-to-paid-conversion-rate-benchmarks

임상 근거

- [6] Jastreboff AM et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity (SURMOUNT-1). NEJM 2022.

- [7] Zepbound/Mounjaro 허가사항 (경고: 급성 콩팥 손상, 췌장염, 담낭 질환, 과민반응, 저혈당)
- [8] Aronne LJ et al. Continued treatment with tirzepatide for maintenance of weight reduction (SURMOUNT-4). JAMA 2024.
- [9] West et al. GLP-1 계열 약 중단 후 체중 재증가 메타분석. BMJ 2026.
- [10] Horn DB et al. 재증가 비율별 심혈관·대사 지표 변화 (SURMOUNT-4 사후분석). JAMA Intern Med 2025.
- [19] 건강 행동 게임화 메타분석. JMIR Serious Games 2025.
- [20] SURMOUNT-MAINTAIN (티르제파타이드 저용량 유지). Lancet 2026.
- [21] Eli Lilly, 티르제파타이드 반감기(약 5일)·체내 소실 안내
- [22] Hollis-Hansen et al. GLP-1 중단 후 구조화 프로그램 파일럿 (n=39, 4개월). 2026.
- [23] NICE Quality Standard QS212, Overweight and obesity management (2025.08)
- [24] Jensen MD et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults.
- [25] Wing RR et al. A self-regulation program for maintenance of weight loss (STOP Regain). NEJM 2006.
- [26] ACLM·ASN·OMA·TOS 공동 권고문, GLP-1 치료 중 영양 우선순위. 2025.